

Diabète sucré : Diagnostic et Classification.

1. Le diabète type 2 (RF) : (RATT 2025 T30)

- A. Survient plus souvent après l'âge de 40 ans
- B. Est souvent associé à un surpoids
- C. Plus fréquent que le DT1
- D. Ne donne presque jamais de complications microangiopathiques
- E. Peut être révélé par un pied diabétique

D Il donne **fréquemment** des complications microangiopathiques (rétinopathie, néphropathie, neuropathie)

2. Le diabète type MODY se caractérise par (RJ) (RATT 2025 T29)

- A. L'absence d'ATCD familiaux de diabète
- B. Apparition tardive après l'âge de 40 ans.
- C. Les complications macroangiopathiques sont fréquentes et précoces
- D. Nécessite souvent une insulinothérapie
- E. Toutes les propositions sont fausses

Le MODY est un diabète monogénique, souvent avec **ATCD familiaux**, à l'apparition **précoce** (avant 25 ans). Les complications macroangiopathiques sont rares. Ne nécessite pas toujours d'insuline, certains répondent aux sulfamides.

3. Chez le diabétique de type 2, l'insulinosécrétion est affectée par les anomalies suivantes sauf une : (la RJ) (P2 2025 T30)

- A. Perte du pic précoce
- B. Réduction de la sécrétion basale
- C. Altérations des oscillations lentes de l'insuline
- D. Altérations de la réponse des cellules Bêta à l'insuline
- E. Augmentation de la clairance hépatique de l'insuline

D	Les cellules bêta ne répondent pas à l'insuline, mais au glucose. L'anomalie de la réponse des cellules bêta est à l'origine du DT2 (perte du pic précoce, réduction de la sécrétion basale, etc.)
----------	--

4. Dans le diabète de type 1 : (les RF) (P1 2025 T36)

1. Le diabète de type 1 idiopathique est le plus fréquente
2. Les ATCD familiaux dans le diabète de type 1 sont fréquents
3. Les complications dégénératives au diagnostic sont absentes.
4. Poids ; Normal ou maigre ;
5. la carence en Insuline, risque d'évolution vers coma acido cétonique

A. 1+2 B. 3+4 C. 1+5 D. 2+4 E. 2+5

A 1 est faux : Le DT1 est majoritairement **auto-immun**, le DT1 idiopathique est rare.

2 est faux : Les ATCD familiaux de DT1 sont rares (5-10%) , on les retrouve surtt dans le DT2 .

3 est vrai : Les complications dégénératives (micro/macroangiopathie) sont **absentes au diagnostic** (contrairement au DT2).

4 est vrai : Le poids est normal ou maigre.

5 est vrai : La carence en insuline (Diabète de type 1) expose toujours au risque de **coma acido-cétonique**.

5. Concernant le diabète insipide : (la RF) (P1 2025 T27)

- A. Se caractérise par une polyurie polydipsie.
- B. La polyurie est faite d'urines hypotoniques
- C. Il est toujours dû à une carence en ADH.
- D. Le traitement fait appel à la desmopressine.
- E. Pour poser le diagnostic on a parfois recours d'une épreuve de restriction hydrique

C Le diabète insipide se manifeste par une polyurie massive faite d'urines hypotoniques (A, B), et le diagnostic nécessite l'épreuve de restriction hydrique (E). Le traitement repose sur la Desmopressine (analogue de l'ADH) (D). C est faux : Il peut être dû à une carence en ADH (**central**) OU à une **résistance rénale à l'ADH(néphrogénique)**.

6. Les causes du diabète secondaire à une pancréatopathie exocrine : réponse fausse(RATT 2024 T14)

A. Pancréatite aigue.

B. Cancer du pancréas.

C. Mucoviscidose.

D. Hémochromatose.

E. Glucagonome.

E -Le glucagonome est une pancréatopathie endocrine et non pas exocrine

7. Dans le diabète de type 1 (Réponses fausses) : (RATT 2024 T13)

1. Le diabète de type 1 idiopathique est le plus fréquent.
 2. Les antécédents familiaux dans le diabète de type 1 sont fréquents.
 3. Les complications dégénératives au diagnostic sont absentes.
 4. Poids normal ou maigre.
 5. Sans insuline, risque d'évolution vers coma acidocétosique.
- A. (1+2) B. (3+4) C. (1+5) D. (2+4) E. (2+5)

A -le diabète de type1 auto-immun est plus fréquent, il représente plus de 90% des cas

-Dans 85% des cas de diabète de type 1 il n'existe pas d'antécédents familiaux de diabète de type 1

8. L'association diabète de type 1 et hyperthyroïdie auto-immune évoque : (P3 2024 T7)

- A. Une néoplasie endocrine multiple type 1 (NEM 1).
- B. Une néoplasie endocrine multiple type 2A (NEM 2A).
- C. Une néoplasie endocrine multiple type 2B (NEM 2B).
- D. Une polyendocrinopathie auto-immune type 1 (PEA type 1).
- E. Une polyendocrinopathie auto-immune type 2 (PEA type 2).

E La polyendocrinopathie auto-immune de type 2 appelée également syndrome de Schmidt est une maladie génétique autosomique dominante se manifestant essentiellement par une insuffisance surrénalienne, une maladie thyroïdienne auto-immune (tel que la maladie de Basedow, la thyroïdite de Hashimoto) et/ou un diabète de type 1.

Elle peut aussi s'accompagner d'hypogonadisme, d'hypoparathyroïdie, d'hépatite auto-immune, de vitiligo, de gastrite auto-immune et d'une myasthénie grave.

C'est une maladie polygénique qui n'a été associée à aucun gène particulier

9. Les causes du diabète secondaire à une pancréatopathie exocrine : réponse Fausse. (P2 2024 T40)

- A- Pancréatite aigue
- B. Cancer du pancréas.
- C- Mucoviscidose
- D- Hémochromatose.
- E- Glucagonome.

E Le glucagonome est une pancréatopathie endocrine et non pas exocrine

10. La physiopathologie du diabète de type 2 comprend : (P2 2024 T29)

- A- Une carence en insuline de façon isolée.
- B- Une résistance à l'insuline de façon isolée.
- C- Une destruction à médiation cellulaire des cellules bêta

D- Une association insulinocarence et insulinorésistance.

E- Une destruction auto-immune à médiation humorale des cellules bêta.

D La physiopathologie du DT2 se base sur 2 grands axes :

• **L'insulino-résistance** : La résistance à l'insuline est une diminution de son action, inhibitrice de la production endogène et stimulatrice de l'utilisation périphérique du glucose (Foie, muscle, tissu adipeux). L'insulinorésistance concerne virtuellement tous les diabétiques de type 2, mais aussi les au cours de l'obésité, de l'HTA... Les effets (anaboliques et anti cataboliques) de l'insuline en dehors du métabolisme glucidique peuvent aussi être réduits, notamment sa capacité à réduire la lipolyse au niveau du tissu adipeux, ce qui est important car les acides gras ainsi libérés contribuent aux perturbations de l'homéostasie glucidique. Cette insulino-résistance est due à un défaut d'action de l'insuline au niveau de son récepteur, mais surtout au niveau de ses substrats et des voies intracellulaires par la présence de TNF-alpha, d'acides gras libres (Lipotoxicité), des glucocorticoïdes ou encore d'anomalies de l'insuline elle-même...

• **L'insulino-déficience** : Face à cette insulino-résistance, le pancréas va devoir augmenter sa sécrétion d'insuline pour maintenir une glycémie normale (On peut donc avoir une insulino-résistance sans diabète, ce qui est fréquent chez le sujet obèse). Mais à un moment donné, le pancréas ne sécrète plus assez d'insuline pour répondre à la demande accrue et une hyperglycémie, d'abord post-prandiale puis à jeun, apparaît. Cette insulino-déficience relative s'explique par une anomalie du métabolisme, de l'excrétion de l'insuline et des voies de signalisation au niveau des cellules bêta. Ces anomalies sont dues à divers facteurs, dont le facteur génétique, l'inflammation induite par l'obésité et les adipokines/cytokines circulantes... Par ailleurs, l'installation du diabète, avec l'hyperglycémie et l'augmentation des acides gras circulants, impactent négativement les cellules bêta et crée donc un cercle vicieux jusqu'à aboutir à une insulino-déficience absolue.

11. Parmi les propositions suivantes concernant le diabète de type 1, lesquelles sont fausses? (P2 2024 T28)

A- Il est caractérisé par une carence absolue en insuline.

B- L'origine auto-immune est la plus fréquente.

C- La cétose est la conséquence d'une carence en insuline D

La cétose résulte d'une dégradation des protéines.

E- Le dosage des auto-anticorps est obligatoire pour poser le diagnostic.

DE -le cétose résulte plutôt d'une dégradation des lipides

-En pratique, dans le D 1, un syndrome cardinal associé à une hyperglycémie supérieure à 2 g/l fait poser le diagnostic le dosage des Anticorps dans le diabète type 1 est indiquer en cas d'absence d'un tableau clinique typique

12. Les facteurs de risques de diabète gestationnel sont : (La ou les réponses justes) (P1 2024 T38)

A. L'obésité.

B. L'âge <30ans

C. Le terrain d'auto-immunité

D. Les antécédents de macrosomie lors d'une grossesse antérieure

E. La primiparité

38 ADB- L'âge $\geq$ 30ans

E- La parité élevée

